



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فاطمه محمد فتحي غانم
المحافظة : القليوبية
الحى / المدينة : شبين القناطر
العنوان : دد
رقم البطاقة : 27301291402846 رقم التليفون : 01280248512
تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 29-01-1973 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي
الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]
التعليق على التشخيص : -----
قسم العلاج : الاورام

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فاطمه محمد فتحي غانم National ID: 27301291402846	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فاطمة
محمد فتحي غانم دياب
الاحراز
مركز شبين القناطر - القليوبية

١٩٧٣/٠٧/٢٩ ٢٧٣٠١٢٩١٤٠٢٨٤٦
JJ5611137

DMS
ن. عيسى
هرموض اراهيم كس

٢٠٢٢/٠٥ ٢٧٣٠١٢٩١٤٠٢٨٤٦
حاصلة على دبلوم تجارة
أنثى مسلمة أرملة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٥/١٥ ١١

Patient Name : الأستاذة / فاطمة محمد فتحى خانم
Patient No. : 27301291402846
Path No. : 3068/24
Sex : Female
Age : 51 Y
Referring Doc :

Request No. : 13004489
Request Date : 25/08/2024
Verification Date : 31/08/2024
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical data
Right breast mass

Nature of specimen
Tru cut biopsy, collected at 24/8/2024, 10:30 am

Gross examination
Multiple grayish white tissue cores up to 1.2 cm, totally submitted.

Microscopic examination
Histological type: Invasive duct carcinoma.
Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+2) Grade II
CIS: No

Angiolymphatic invasion: Couldn't be detected in the received biopsy
Perineural invasion: No

Diagnosis
Right breast mass, Tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II.
Immunohistochemistry (IHC) (ER, PR, HER2, Ki67)

Signature
Dr. Rana Fathy
Dr. Heba Hassan

Verified by :
Dr. Heba Hassan

Date : 09/09/2024 10:09:03

Page 1 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy

Name: فاطمه محمد فتحي غانم		
MR. : 5016		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient was diagnosed with invasive ductal carcinoma of the right breast, staged pathologically as PT2 N1 M0 following breast-conserving surgery with axillary lymph node dissection. Hormone receptor testing demonstrated estrogen receptor (ER) 8/8 and progesterone receptor (PR) 8/8 positivity, with HER2 0. The adjuvant plan initiated on the day of surgery included an aromatase inhibitor (ARAMIDEX) and intravenous bisphosphonate therapy (ZOMETA). Post-operative assessment confirmed right-sided breast cancer with clinical stage cT4b N1. Pathology reiterated ER 8/8, PR 8/8, and HER2 negative status. The multidisciplinary team recommended neoadjuvant chemotherapy consisting of 4 cycles of AC (doxorubicin and cyclophosphamide) followed by 12 cycles of taxol, which was administered on 20/04/2025. Ongoing adjuvant therapy was planned with ARAMIDEX and ZOMETA, and imaging follow-up (right mammogram) was scheduled, with the most recent study in April 2025 reported as BIRADS 1. The patient continues on ARAMIDEX with supportive care for a planned duration of three months. The next outpatient oncology visit is scheduled for 22/09/2026.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	الطبيب المعالج : نهى سعيد علي محمد	
يعتمد ,		

Patient Name: Fatma Mohamed Fat'hy Ghanem Diab	Date : 09/09/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 3073/2024	Pat. ID: 78909

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

****A case of right breast cancer**

Findings:

I-Chest: -

- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

IX- Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions (on non contrast base) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys (apart from left renal middle calyceal radiodense stone measuring about 4 mm) with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs, yet bulky RVF uterus.



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:
1- Name : فاطمة محمد قنجر غلام
2-10 number: 27301291402846

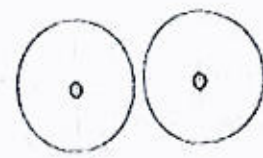
Sex:

3- Medical number:
Female

83230912
Old Med :

01/01/2024
3073-2024

Patient Age : 52 Y



Family history	Family history	Phone	01280248522	BMI		REASON OF MDT	REASON OF MDT
marital status	Marital status	NRS Score		GROUP	GROUP	Date of MDT	Date of MDT
Co morbidity	Co morbidity	Menopausal status	Menopausal status	Initial STAGE	Initial STAGE	2025-05-26	

Clinical data

Breast Imaging :
ecr c RT BREAST MULTIPLE LESIONS OCCUPYING MOST OF
INNER, OUTER UPPER QUADRANTS

Mets Workup :
CT : NO EVIDENCE OF PULMONARY , HEPATIC OR
OSSEOUS METASTATIC DEPOSIT

BX IDC BX COMMENT	ER 8/8 ER COMMENT	PR 8/8 PR COMMENT	Her 2 Neu 0 Her 2 Neu COMMENT	SISH SISH COMMENT	Ki67 10
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------	------------

T CT4B FOCAL SKIN INFIL TERATION OF THE AREOLA	N 1	M 0
---	--------	--------

Sonomammography
cesm:rt breast BIRADS 6 UOQ & upper central mass & non mass pathological process
lt brEAST BI RADS 2 diffuse fibrocystic changes

PATIENT HISTORY
ended NACT AC X4-->4 taxotere ended 18/3/2025 , 2 CLIPS WERE INSERTED
on ex: still has breast mass 4x4 cm
NEW SM NO RESIDUAL
SM:IDC GII
free nipple , areola LN 0/5
YPT2N1 FOCALLY POSITIVE DEEP MARGIN
SURGERY: FLUSHED MARGIN FOR NO MORE SURGICAL INTERVENTION
MDT OUTCOME & PLAN

ADJUVANT ZOLADEX AT
PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
SURGERY		